SDD 161 Sujet n°1

Spécialité : Cardiologie

Date : 01/09/2023
Auteur : CHABANE Nadhir (DES de Cardiologie - ECN 2021)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de Médecine interne - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item(s) en lien avec la station	230 Douleur thoracique 339 Syndromes coronariens aigus
Situation(s) de départ en lien avec la station	161 Douleur thoracique
Matériel nécessaire à la station	Table, 2 chaises, 1 ECG
Contexte de la station	

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un urgentiste au déchocage. Vous recevez M. M.
Votre collègue du SMUR vous transmet :
Homme de 75 ans, hypertendu, diabétique, tabagique à 40 PA présente depuis environ 13h une douleur thoracique gauche d'apparition brutale sans traumatisme.

Pas d'irradiation. Pas de modification de la douleur. Pas de dyspnée.

L'auscultation cardio-pulmonaire est normale.
Le patient est traité par METFORMINE 1000 mg, AMLODIPINE 10mg, RAMIPRIL 10mg.

Vous avez déjà réalisé un des examens complémentaires qui est disponible devant vous.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer vos hypothèses diagnostiques dans ce contexte
- Enoncer les examens complémentaires nécessaires à réaliser ici
- Interpréter l'iconographie présente devant vous et énoncer votre suspicion diagnostique

Vous ne devez pas :

- Interroger un patient
- Réaliser un examen clinique

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Item 230 - Douleur thoracique & Item 339 - Syndrome coronarien aigu	Points
COMPETENCES CIBLEES	
Rubrique 1 : Hypothèses diagnostiques	
Évoque la péricardite	1
Évoque l'infarctus du myocarde	1
Évoque l'embolie pulmonaire	1
Évoque la dissection aortique	1
Évoque le pneumothorax	1
Rubrique 2 : Examen complémentaire	
Demande une radio thoracique	1
Demande un bilan biologique comprenant : NFS, Ionogramme-Créatinine, Hémostase TP/TCA ok si 3/5	1
Demande une troponinémie	1
Demande des D-Dimères	1
Demande un ECG 18 dérivations	1
Rubrique 3 : Lecture ECG	
Décrit un ECG 12 dérivations	1
Décrit un sous-décalage du segment ST diffus	1
Décrit le sus décalage du segment ST en aVR	1
Évoque une étiologie ischémique à la douleur thoracique	1
Rubrique 4 : Hypothèse diagnostique finale	
Émet l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu.	1
POint BONUS : Évoque un atteinte du tronc commun gauche	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à communiquer	1
Total	**18**

Éléments de rétroaction :

- M. M, 75 ans, est amené aux urgences pour une douleur thoracique
- Antécédents et traitements sont déjà donnés dans la consigne
- Douleur basithoracique gauche brutale, sans irradiations. Douleur atypique « qui fait mal » mais difficile à décrire.

Le candidat médecin devra compléter l'interrogatoire de M. M en fonction des hypothèses diagnostiques et énoncer les examens complémentaires nécessaires.

Nous n'abordons pas la prise en charge thérapeutique dans cet ECOS.

Hypothèses attendues :
PIED :
- Pneumothorax, Pneumopathie, Pleurésie, Péricardite
- Infarctus du myocarde
- Embolie pulmonaire
- Dissection Aortique

Dans le détail :
- Pneumothorax
  - Interrogatoire : Pas de dyspnée, pas de traumatisme, patient de 90kg pour 1m70
  - Examen clinique : Murmure vésiculaire bilatéral et symétrique. Pas d'anomalie de la mécanique ventilatoire et de l'ampliation pulmonaire gauche.
  - Examens complémentaires : Radio thoracique normale
- Pneumopathie, Pleurésie, Péricardite
  - Interrogatoire : Douleur non majorée par l'inspiration. Pas de modification de la douleur lors du changement de position.
  - Examen clinique : Pas de fièvre, pas de signes droits
  - Examens complémentaires : Radio normale, Pas de sus-décalage diffus concave vers le haut.
- Infarctus du myocarde
  - Interrogatoire : Douleur brutale
  - Examen clinique : Pas de signes de décompensation cardiaque.
  - Examens complémentaires :
    - ECG : donner l'ECG et demander une interprétation
    - Troponine à 14 000ng/L (N<14 ng/L)
    - ETT : FEVG 40%, hypokinésie antérieure, antéroseptale et antérolatérale. Fonction VD conservée. Pas de valvulopathie significative.
- Embolie pulmonaire
  - Interrogatoire et Examen clinique : Pas de tachycardie, pas de dyspnée, pas de désaturation, pas d'hémoptysie. Pas de syncope. Pas de grosse jambe rouge ni œdématiée.
  - Pas de voyage, pas de chirurgie récente, pas de cancer, pas d'immobilisation.

Tableau 2 : Scores de probabilité clinique d'EP (= probabilité pré-test).

Score de WELLS*	
Antécédents personnels d'EP ou TVP	+ 1,5
Chirurgie ou immobilisation <4 semaines	+ 1,5
Cancer actif	+ 1
Hémoptysie	+ 1
FC > 100/min	+ 1,5
Signes de TVP	+ 3
Diag. alternatif - probable que celui d'EP	+ 3
Score de Wells	
Probabilité clinique : ***☐ faible (0-1)*** ***☐ intermédiaire (2- 6)*** ***☐ forte (≥ 7)***	

Score modifié simplifié de GENÈVE*	
> 65 ans	+ 1
Antécédent personnel d'EP ou TVP	+ 1
Chirurgie ou immobilisation	+ 1
Cancer actif	+ 1
Hémoptysie	+ 1
Douleur spontanée mollet	+ 1
FC 75-94 /min	+ 1
FC ≥ 95/min	+ 2
Signes de TVP (œd/ douleur provoquée)	+ 1
Score révisé de Genève	
Probabilité clinique : ***☐ faible (0-1)*** ***☐ intermédiaire (2-4)*** ***☐ forte (≥ 5)***	

*il n'est pas attendu de savoir calculer le score. L'important est que l'étudiant sache qu'avec des éléments cliniques simples on peut estimer la probabilité clinique

Score de WELLS à 0

Score de Genève à 2 (Age > 65 ans et FC entre 75-94)

- Examens complémentaires : D-Dimères négatifs

- Dissection Aortique
  - Interrogatoire : Pas d'irradiation dans le dos.
  - Examen clinique : Pas de signes d'ischémie périphérique.
  - Examens complémentaires : D Dimères négatifs